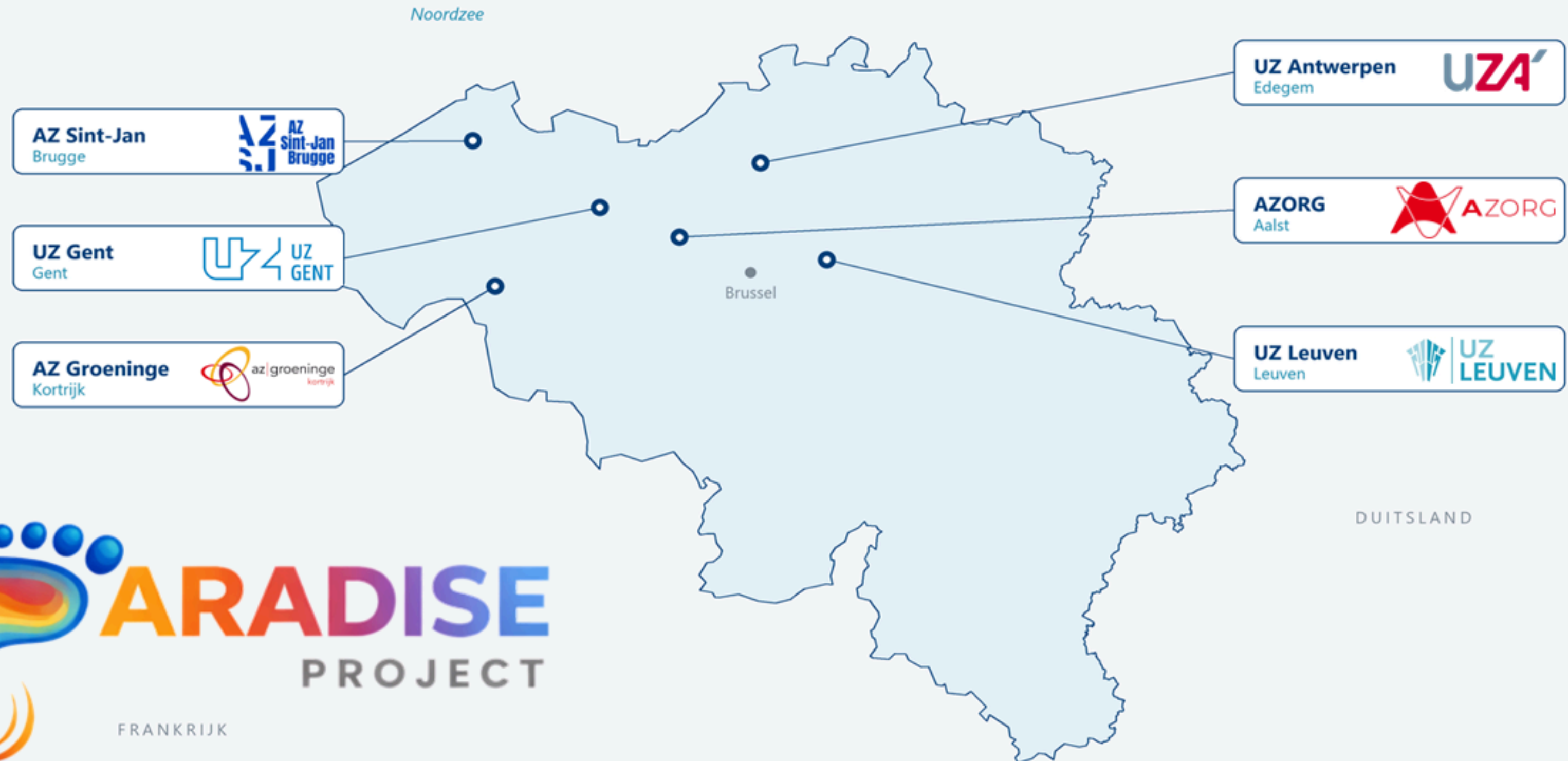


Eerste officiële meeting

12 OKTOBER 2026



AGENDA

Wat we vandaag overlopen

- 01 Stand van zaken
- 02 Ontwikkelingen sinds 1 april
- 03 Werkpakketten
- 04 Aandachtspunten
- 05 Mijlpalen en planning
- 06 Bespreking
- 07 Tour de table



1 • STAND VAN ZAKEN

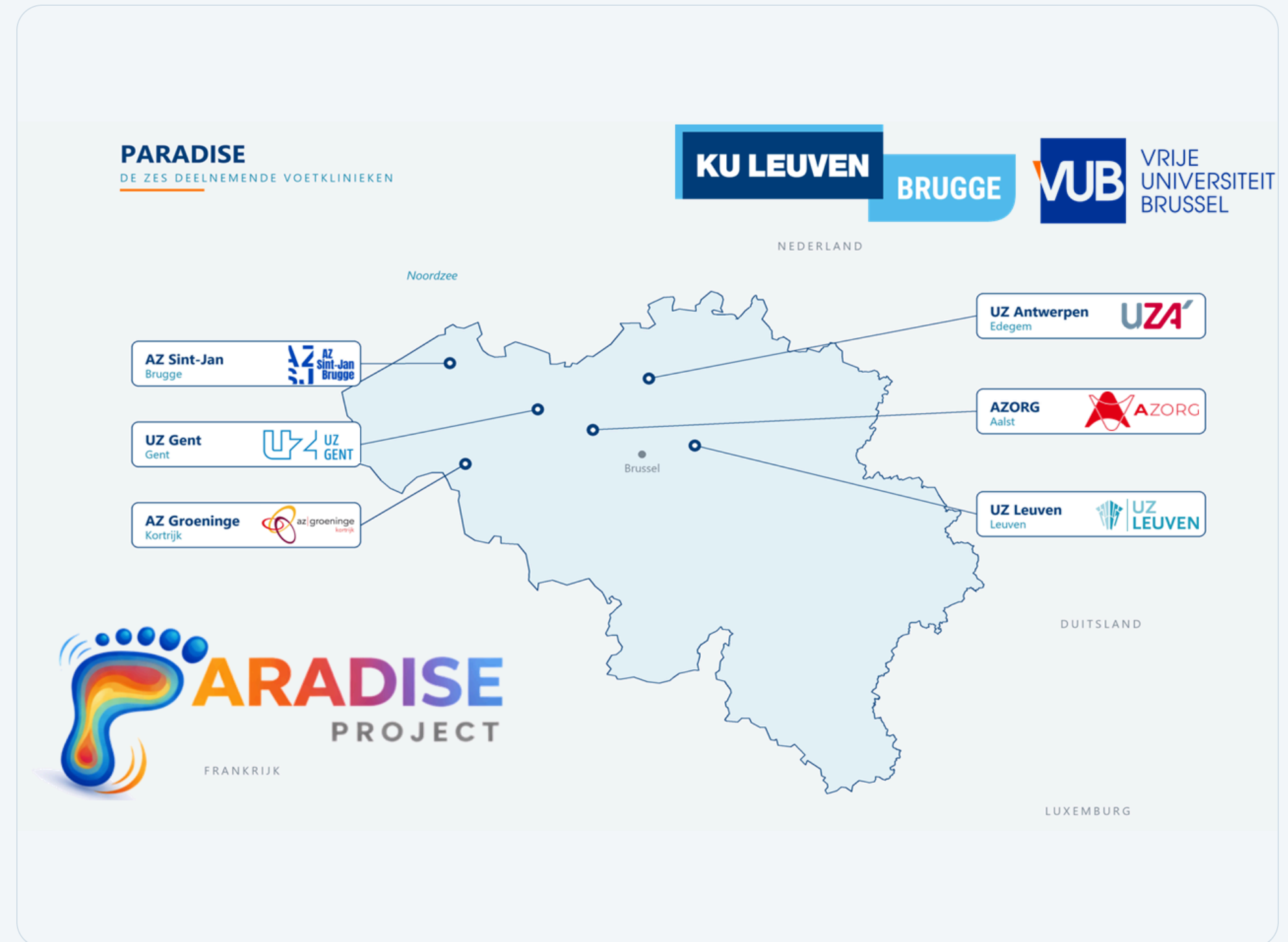
144 deelnemers, zes voetklinieken

24 per centrum: 12 in PARADISE, 12 in gebruikelijke zorg

18 maanden opvolging per deelnemer

1 primair eindpunt: voetulcusrecidief over 18 maanden

De PI loot per centrum, met verzegelde enveloppen.



Waar we vandaag staan

Drukmeting

Novel pedar geleverd; installatie loopt

Databank

REDCap klaar; u werkt op papier

Opleidingen

10 november tot maart

Start

Februari 2027: piloot, Go/No-Go, eerste patiënt



Goedkeuring per centrum

CENTRAAL · EC UZ LEUVEN ...

FAGG ...

Centrum	Lokaal ingediend	Goedgekeurd	Contract	Opmerking
AZ Groeninge Kortrijk				
AZ Sint-Jan Brugge				
UZ Gent				
AZORG Aalst				
UZ Leuven				
UZ Antwerpen				

PER VAKJE  Rond  In behandeling  In voorbereiding  Nog niet gestart

Materiaal per centrum

Materiaal	Kortrijk	Brugge	Gent	Aalst	Leuven	Antwerpen
Novel pedar: laptop, router en twee zenders						
Vier MoveMonitors						
Orthotimers en de pen						

PER VAKJE



Geïnstalleerd



Aanwezig



Onderweg



Niet aanwezig

Wat intussen vastligt

DRUKMETING

Novel pedar in de kliniek

F-Scan GO alleen bij het studieteam

DRUKNORM

< 200 kPa óf $\geq$ 25% lager

EINDPUNT

Recidief over 18 maanden

therapietrouw is de mediator

DRAAGNORM

80% van de eigen waaktijd

MoveMonitor alleen bij de start

CMFO

Opbouw per schoentype

plus een identiek tweede paar

BLINDERING

Geen drukwaarden in gebruikelijke zorg

DATA

REDCap klaar

u werkt op papier, wij zetten over

REKRUTERING

12 maanden

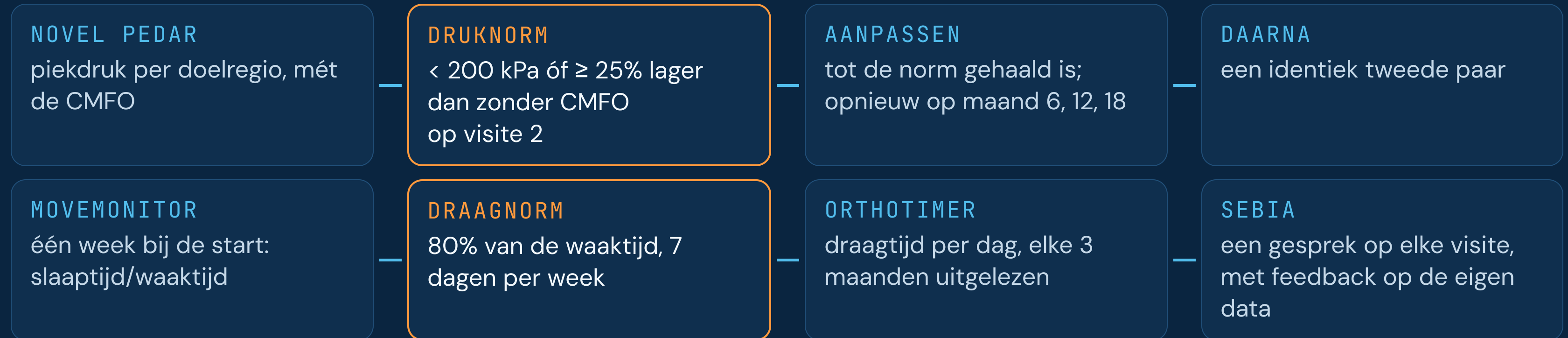
februari 2027 tot februari 2028



Zelfde metingen, ander gebruik

BEIDE ARMEN CMFO · voetzorg elke 3 maanden · dezelfde metingen · MoveMonitor en Orthotimer

PARADISE, OF OPTIMAL CARE · TWEE NORMEN



USUAL CARE Dezelfde metingen, geblindeerd: geen toetsing, geen feedback



Eén week MoveMonitor, een norm op maat

01 • BIJ DE START: ÉÉN WEEK MOVEMONITOR

wakker 15,5 u

slaap 8,5 u

opstaan

slapengaan

02 • DE NORM: 80% VAN DIE WAAKTIJD, ZEVEN DAGEN PER WEEK

schoeisel aan: 12,4 u

03 • DE BOODSCHAP

“U draagt uw schoenen altijd, van het moment dat u opstaat tot u gaat slapen.”

WAT VERANDERT

De meetweek op maand 6 vervalt: minder werk voor uw team.



De 80% komt uit één studie

DIAFOS • BUS E.A. 2013

80% van de stappen

vooraf gekozen om twee **even grote groepen** te maken

RECIDIEF BIJ WIE 80% HAALDE • N = 79

drukverlagend schoeisel



gebruikelijke zorg



WAAIJMAN E.A. 2013 • 107 DIAFOS-PATIËNTEN

Zelfde week, twee getallen

dezelfde patiënten, dezelfde meetweek

GEMIDDELDE THERAPIETROUW

van alle stappen gezet in de schoen



van een aangenomen dag van 16 uur (9,4 u gedragen)



80% van de stappen is niet 80% van de dag. **PARADISE rekent in uren van de gemeten waaktijd.**



Iedereen koos een andere noemer

GEDEELD DOOR	DAG niet gemeten, meestal 16 u	STAPPEN geen daglengte nodig	UREN PER DAG zonder noemer	GEWICHTDRAGENDE TIJD staan en stappen, gemeten	GEMETEN WAAKTIJD per patiënt
Chantelau 1994 geen sensor	> 60%	—	—	—	—
Arts 2014 zelfrapportage	60%	—	—	—	—
Waijman • Bus 2013 @monitor + StepWatch	—	80%	—	—	—
DIASSIST 2023 • 2026 Orthotimer + MoveMonitor	—	uitkomst	< 8 u	—	—
Exterkate 2023 Orthotimer	60% en 80%	—	—	—	—
van Netten 2025 Orthotimer + MoveMonitor	—	< 80%	< 8 u	—	—
Jarl 2023 Orthotimer + MoveMonitor	—	77,4%	12,2 u	80% • ref.	—
PARADISE Orthotimer + MoveMonitor bij de start	—	—	—	—	80%

Drie studies gebruiken dezelfde toestellen als PARADISE; geen enkele deelt door een gemeten waaktijd.

Wat we overnemen, en wat niet

OVERNEMEN

De 80% als lat

uit DIAFOS: bij wie ze haalde, werkte het drukverlagend schoeisel

Dezelfde toestellen

Orthotimer en MoveMonitor, zoals DIASSIST, van Netten en Jarl

Draaguren als maat

volgen de referentie bijna even goed als de stappen (Jarl)

% van de stappen		$r = 0,96$
uren per dag		$r = 0,91$
zelfrapportage		$r = 0,42$

Een lat rond 12 uur

Jarl: 12,2 u per dag; onze lat bij 15,5 u wakker: 12,4 u

NIET VOOR PARADISE

% van de stappen

McRoberts levert alleen dagtotalen, geen data per tijdstip

Een aangenomen dag van 16 uur

wij meten de eigen waaktijd

MoveMonitor op 6 en 12 maanden

zoals in het DIASSIST-protocol; bij ons alleen bij de start

Zelfrapportage

volgt de referentie maar matig ($r = 0,42$)

Wie komt in aanmerking

Wel · onthoud VOETEN

- V** **Vaten stabiel**
Stabiele vaatstatus
- O** **Ooit een voetwonde**
IWGDF-risico 3: genezen plantair ulcus, partiële voetamputatie of resectie van een metatarsaalkop (ook de eerste), 2 weken tot 18 maanden geleden
- E** **Eigen stappen**
Stapt zelfstandig blootsvoets, zonder hulpmiddel
- T** **Type 1 of 2**
Diabetes type 1 of 2
- E** **Echt beschermend schoeisel**
Beschermend schoeisel, of bereid over te schakelen
- N** **Nederlands en volwassen**
18 jaar of ouder, begrijpt Nederlands

Niet

- ✗ Amputatie proximaal van de MTP-gewrichten
- ✗ Actief voetulcus of Charcot-deformiteit
- ✗ Kritische ischemie (PEDIS 3: enkeldruk < 50, teendruk < 30 of TcPO₂ < 30 mmHg)
- ✗ Nierfunctievervangende of immunosuppressieve therapie
- ✗ Verwachte overleving < 18 maanden
- ✗ Kan niet toestemmen of de instructies niet volgen
- ✗ Enkel-voetorthese of ander hulpmiddel dat de sensoren belemmert
- ✗ Weigert het schoeisel of de draagsensor

Screening plus negen visites

Scr screening	V0 geschikt	V1 baseline	V2 14 d–1 m	V3 m 3	V4 m 6	V5 m 9	V6 m 12	V7 m 15	V8 m 18	WAT · TOESTEL
arts	PI									Toestemming en loting arts, dan PI
		A	A + B		A + B		A + B		A + B	Drukmeting Novel pedar
		1 week								Waaktijd MoveMonitor
			start	uitlezen	uitlezen	uitlezen	uitlezen	uitlezen	uitlezen	Draagtijd Orthotimer
		educatie	schoenen	feedback	evaluatie	feedback	evaluatie	feedback	afronding	SEBIA-gesprek alleen PARADISE

A = in de schoen, zónder de CMFO · B = mét de CMFO · op V1 en vanaf V3 ook voet- en schoeiselscreening

PARADISE op Kortrijk Kerngezond



Zes dagen zorginnovatie in Kortrijk. PARADISE toont er hoe we meten.

01 Een korte demonstratie

Hoe meet je de druk onder een voet?

02 Een stand

Met animatievideo

03 Samen met AZ Groeninge

KU Leuven Campus Brugge

KERNGEZOND 16 tot 24 oktober 2026 • K in Kortrijk, tegenover het Rode Kruis

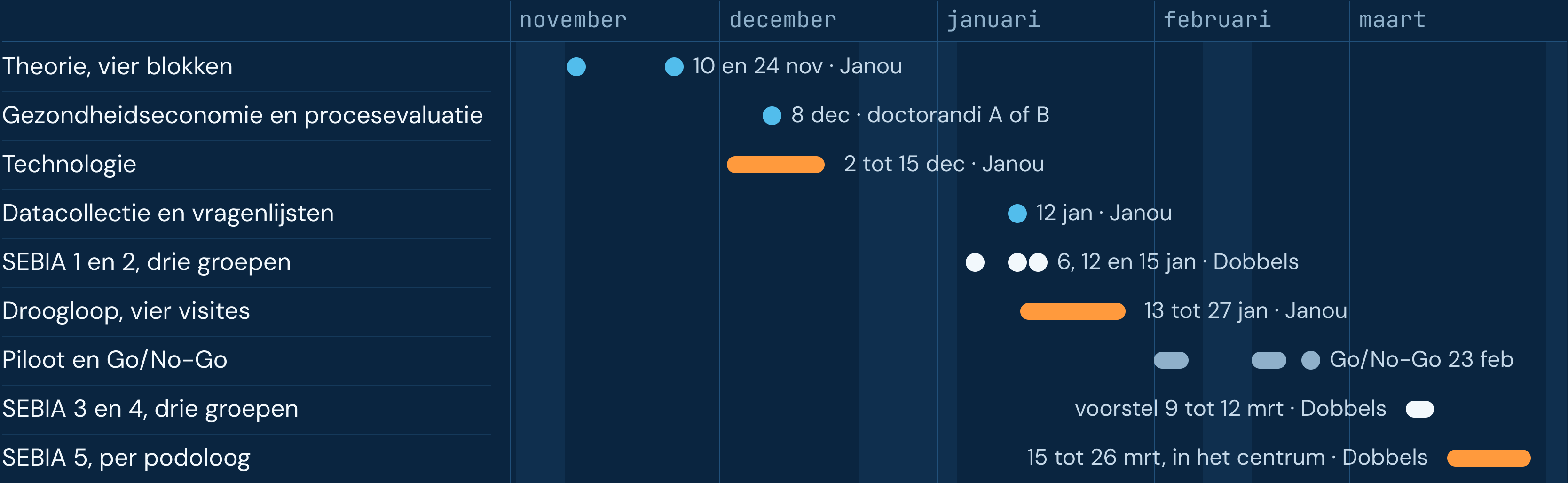
PARADISE 16 oktober

Wat nog moet gebeuren

- | | | |
|----|---|---------------------------|
| 01 | Ethische goedkeuring: centraal, FAGG en lokaal | lokaal: januari |
| 02 | Drukmeting, Orthotimer-software en MoveMonitors geïnstalleerd | vóór uw technologiesessie |
| 03 | Opleiding | 10 november tot maart |
| 04 | Dryrun en pilootbezoek | 13-27 jan • 1-19 feb |
| 05 | SEBIA-schema: het script of het manuscript | te beslissen |
| 06 | Aparte toestemming voor opnames (eCRF 02) | vóór de EC-indiening |

Van november tot maart

● online, opgenomen ● ter plaatse ● centraal □ vakantie



Artsen: alleen de theorie · online sessies worden opgenomen · SEBIA 6 online, sep–nov 2027

Zes sessies, van educatie naar therapietrouw

Het SEBIA-gesprek komt op elke visite van de PARADISE-arm terug. Fabienne leert het de podologen aan.

JANUARI • 4 U

1 + 2

Educatie en feedback

teach-back en show-me
voetzorg voordoen
kennis toetsen (NAFF)
feedback op de draagtijd

overdag, drie groepen

MAART • 4 U

3 + 4

Motiverende gespreksvoering

motivatie inschatten
interventie op maat

overdag, drie groepen (voorstel)

15-26 MAART • 1,5 U

5

Oefenen

rollenspel met de scripts

in uw centrum, individueel

SEP-NOV 2027 • 1 U

6

Intervisie

casussen bespreken
bijsturen

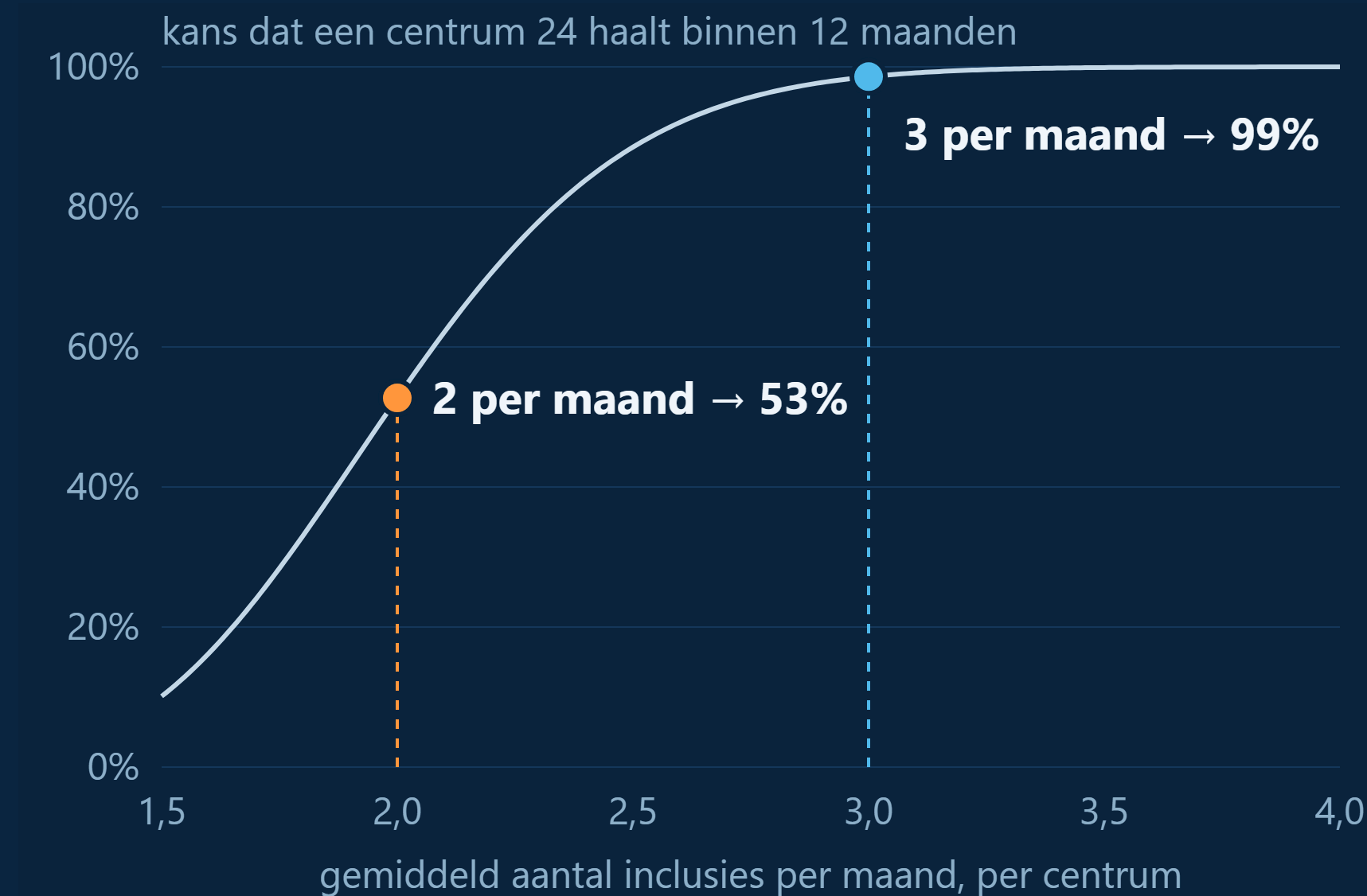
online, individueel

Uw data, zoals voorgesteld

Centrum	Technologie	SEBIA 1 en 2	Droogloop	Inhaalslot
AZ Groeninge Kortrijk	wo 2 dec, VM	wo 6 jan, 13u–17u, met Brugge	wo 20 jan	ma 25 jan, NM
AZ Sint-Jan Brugge	wo 2 dec, NM	1e wo 6 jan · 2e di 12 jan, 13u–17u	wo 13 jan, NM	ma 18 jan, VM
UZ Gent	do 10 dec, VM	vr 15 jan, 13u–17u, in UZ Gent	do 21 jan, 8u–12u30	vr 22 of do 28 jan
AZORG Aalst	do 10 dec, NM	Oost · di 12 jan, 13u–17u	di 19 jan	do 21 jan, NM
UZ Leuven	di 15 dec, VM	Oost · di 12 jan, 13u–17u	di 26 jan	vr 22 jan
UZ Antwerpen	wo 9 dec, VM	Oost · di 12 jan, 13u–17u	wo 27 jan, VM	do 28 jan, VM

Waar het niet voor iedereen lukt, staat een optie B op uw toetsingsblad. Antwoord graag tegen vrijdag 16 oktober.

Drie per maand, binnen een jaar



99%

kans dat een centrum zijn 24 haalt binnen het jaar

92%

kans dat alle zes het halen binnen het jaar

7,9

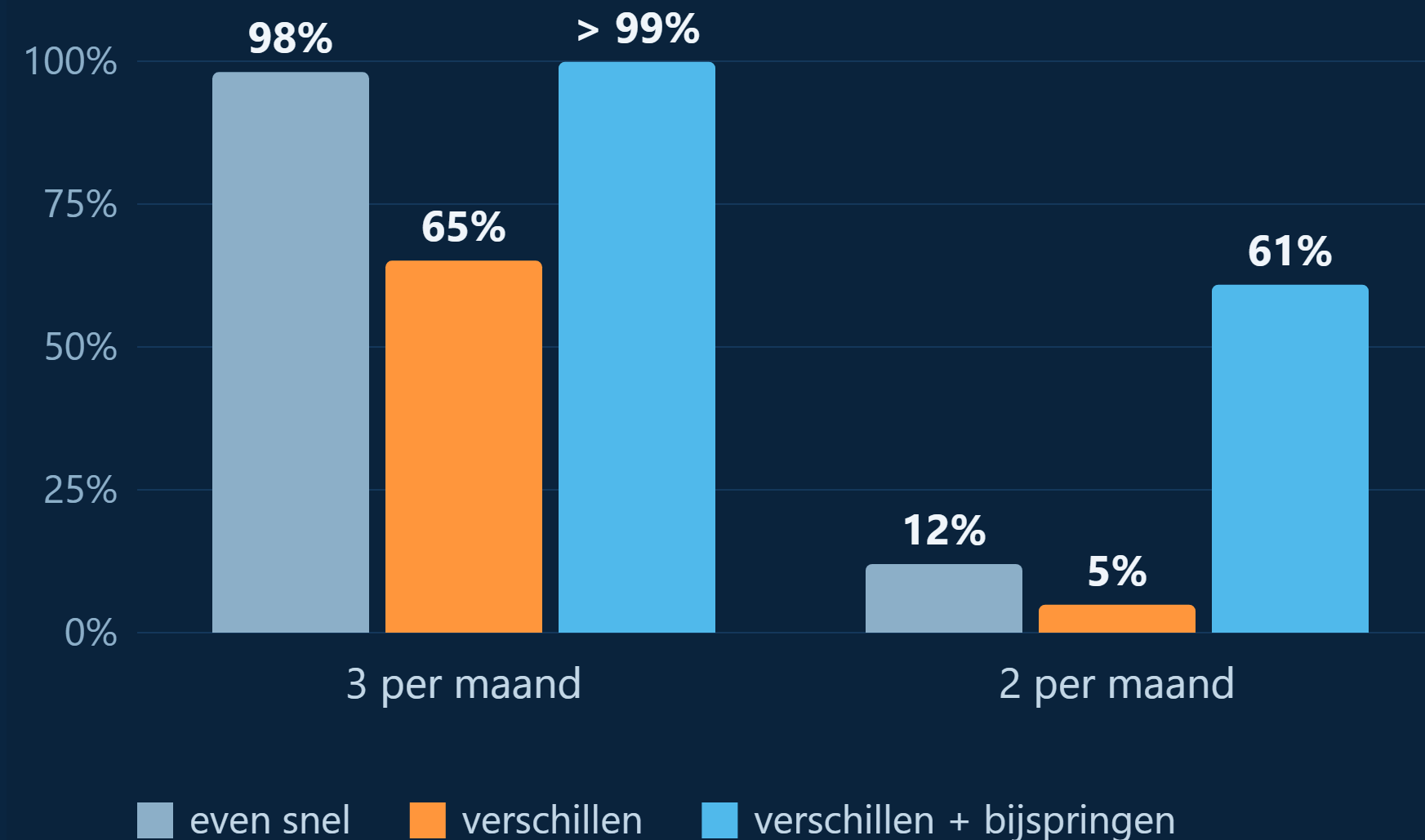
maanden tot 24 inclusies, mediaan per centrum

Volgens plan: laatste visite eind augustus 2029



Het traagste centrum bepaalt het einde

kans dat alle 144 er zijn vóór eind maart 2028



ALLE CENTRA EVEN SNEL
elk centrum haalt het gemiddelde

CENTRA VERSCHILLEN

het ene een kwart meer, het andere een kwart minder

MET BIJSPRINGEN

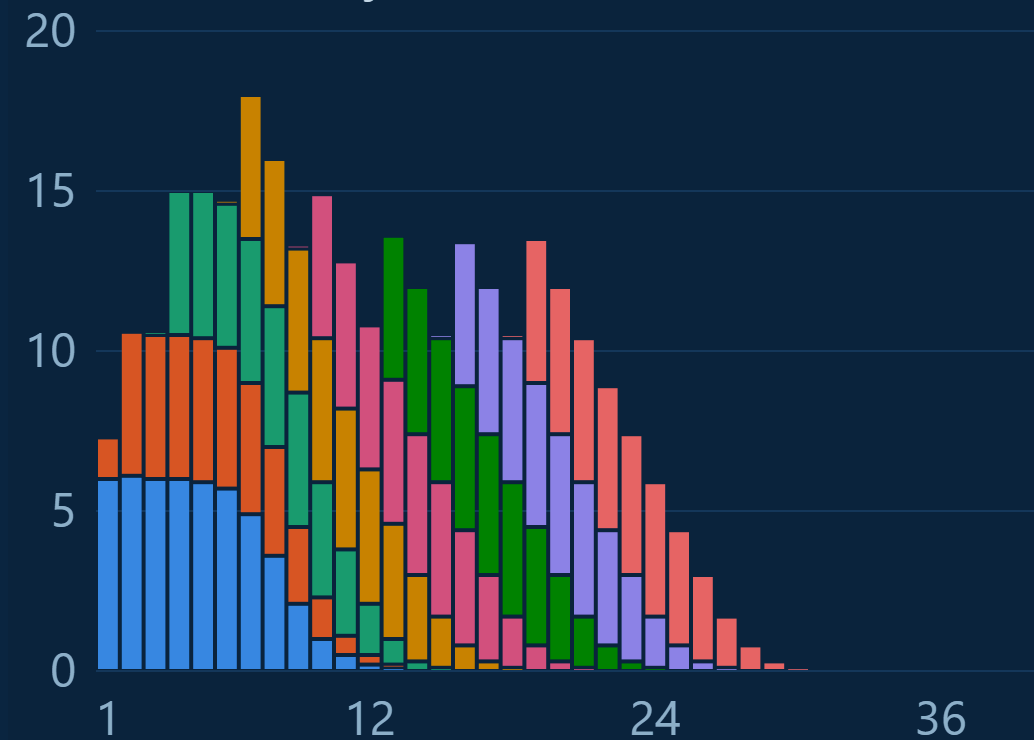
wie sneller gaat, includeert door, tot 30 per centrum

Drie per maand én bijspringen maken het zeker

Evenveel uren, sneller klaar

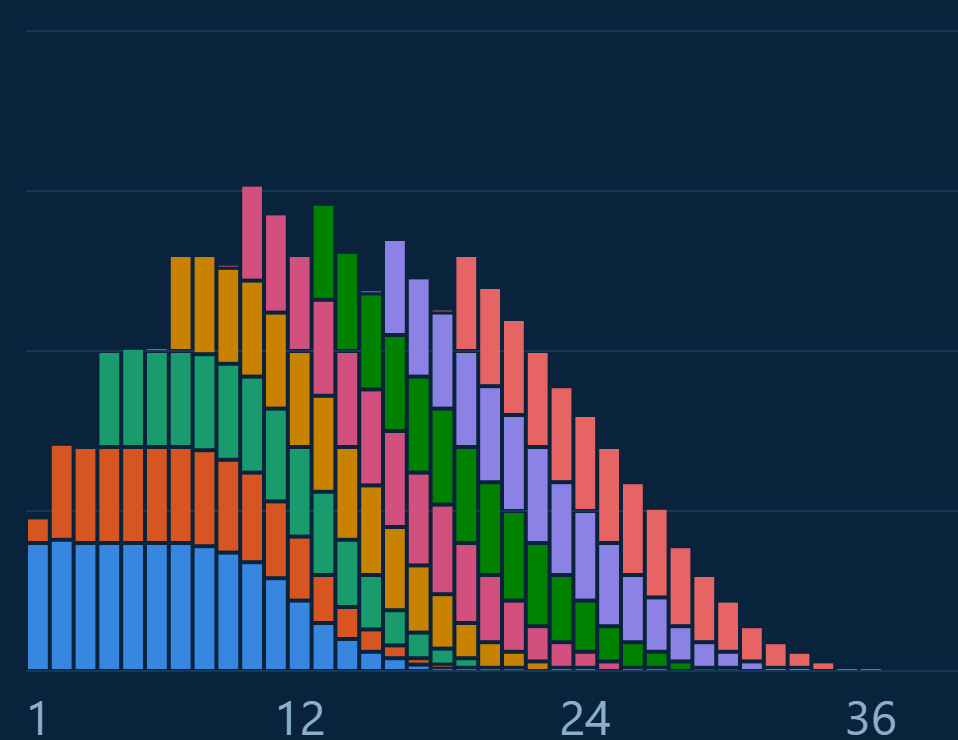
3 per maand 12 maanden inclusie

14,0 u/maand tijdens de inclusie
laatste visite jun 2029 (mediaan)



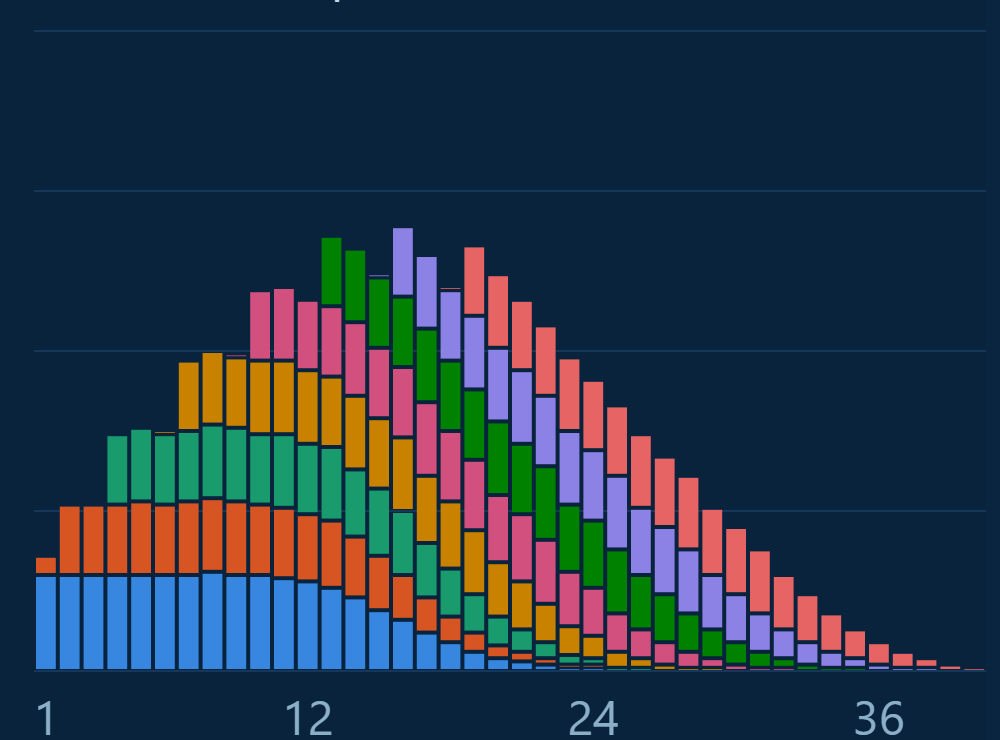
2 per maand 18 maanden inclusie

11,4 u/maand tijdens de inclusie
laatste visite nov 2029 (mediaan)



1,5 per maand 18 maanden inclusie

10,0 u/maand tijdens de inclusie
laatste visite apr 2030 (mediaan)



■ Visite 1 ■ Visite 2 ■ Maand 3 ■ Maand 6 ■ Maand 9 ■ Maand 12 ■ Maand 15 ■ Maand 18

maand na de start

Elk tempo vraagt 300 uur per centrum. Trager includeren spreidt ze, maar schuift de laatste visite naar 2030.



Wat we vragen, en wat we voorleggen

WAT WE VRAGEN

- 01 **Drie inclusies per maand**
- 02 **Een screeningslog** vanaf de eerste patiënt
- 03 **Het toetsingsblad terug** tegen vrijdag 16 oktober
- 04 **Wie deelneemt** podologen en artsen
- 05 **De drukmeting geïnstalleerd** vóór december

TER BESPREKING

Bijspringen als een centrum achterblijft

Welk plafond per centrum? Extra enveloppen?

Twaalf maanden inclusie, geen achttien

Evenveel uren, meer tijd voor de verwerking.

Het logo, ter goedkeuring



Licht: formulieren en patiëntenmateriaal



Nieuw idee uitwerken



Symbool: klein formaat

Akkoord om dit logo overal te gebruiken, of zijn er aanpassingen?

Per centrum, kort

01

AZ Groeninge

Kortrijk

02

AZ Sint-Jan

Brugge

03

UZ Gent

Gent

04

AZORG

Aalst

05

UZ Leuven

Leuven

06

UZ Antwerpen

Edegem

Vijf werkpakketten, één studie

WP1

De klinische studie

studieteam KU
Leuven

Protocol en eCRF's
klaar; opleiding,
piloot, inclusie

WP2

Procesevaluatie

Maaïke Fobelets, VUB

Opnames,
interviews, fidelity
van SEBIA

WP3

Gezondheidseconomie

Koen Putman, VUB

Levenskwaliteit, zorggebruik,
productiviteit

WP4

Project- en databeheer

Kevin Deschamps,
KU Leuven

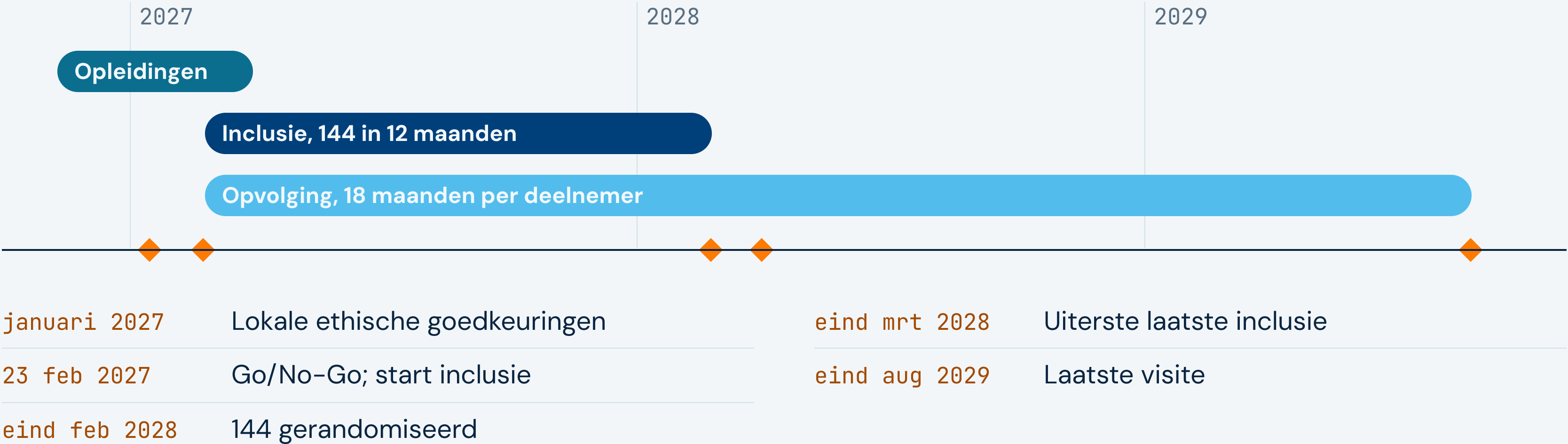
REDCap, ManGO
en de
overlegorganen

WP5

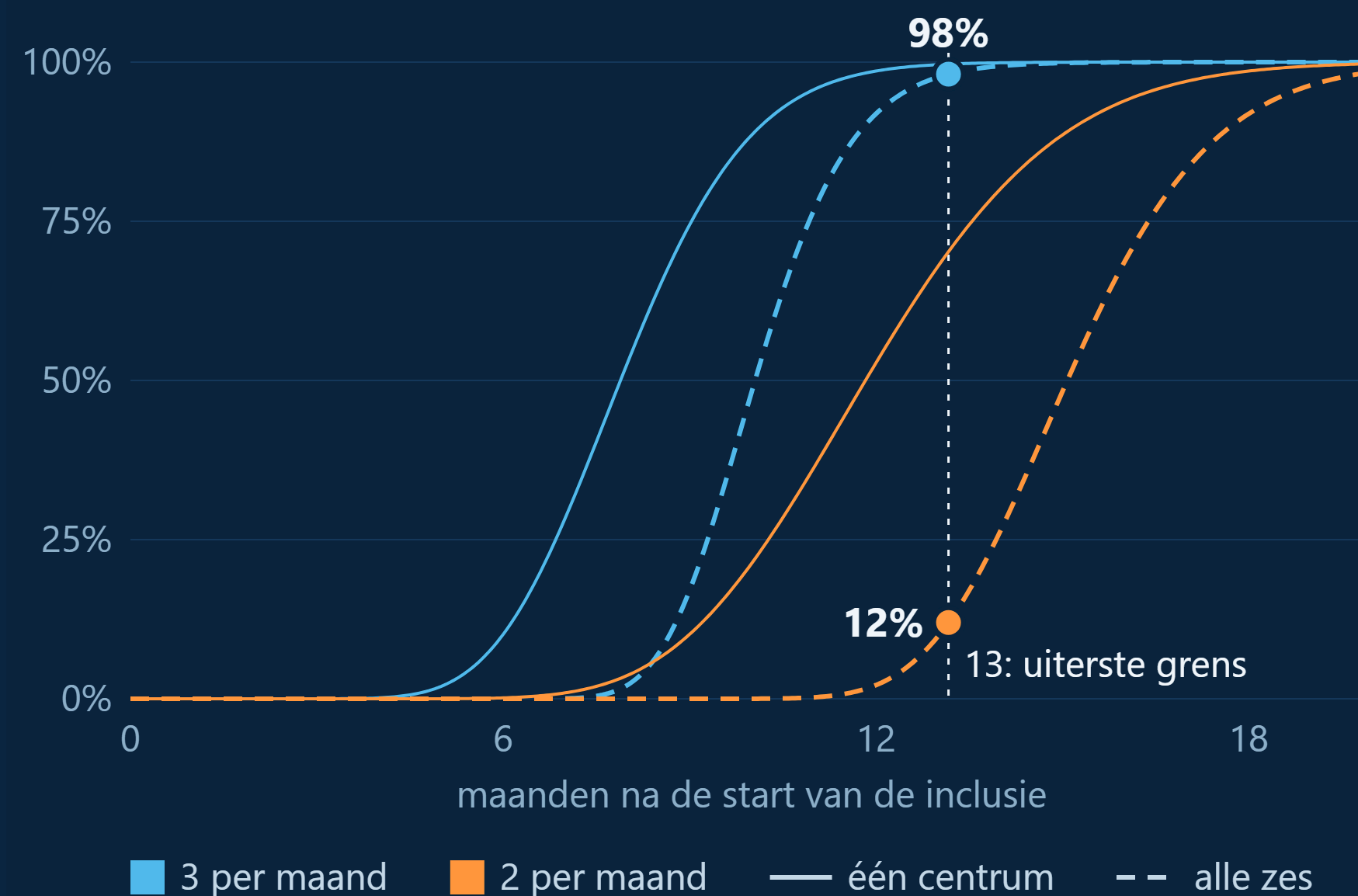
Disseminatie

Website,
publicaties,
communicatie

Van de opleiding tot de laatste visite



Dan valt de laatste visite na september 2029



TWEE PER MAAND

$12 \pm 2,5$ maanden per centrum

3 van 6 centra klaar na een jaar

12% kans dat alle zes klaar zijn vóór eind maart 2028

8% kans dat na 18 maanden nog een centrum niet rond is

Mediaan: laatste visite eind november 2029